

Gestante de 30 semanas con dolor abdominal y contracciones

Caso clínico de Obstetricia · Nivel: estudiante de grado · Código: OB-03

Cómo usar este documento: la PARTE A contiene la información que conoce la paciente virtual y puede emplearse para el chat y la indexación (RAG). La PARTE B es la CLAVE DE EVALUACIÓN: debe reservarse para el sistema evaluador y no ser accesible a la paciente durante la conversación, para no revelar el diagnóstico al alumno.

PARTE A · FICHA DE LA PACIENTE (para el chat / RAG)

Datos de filiación

Nombre	Sara G. N.
Edad	29 años
Profesión	Administrativa
Estado civil	Casada
Fórmula obstétrica	G2 P0 A1 (aborto espontáneo en 1er trimestre)
Edad gestacional	30 + 0 semanas

Motivo de consulta

Desde hace 4 horas nota el vientre que se le pone duro de forma repetida y dolor en bajo vientre.

Antecedentes

Personales	Infección urinaria hace 1 semana, no tratada por completo.
Familiares	Sin interés.
Gineco-obstétricos	Un aborto espontáneo previo en semana 9. Embarazo actual normal hasta hoy.
Hábitos	Fuma 5 cigarrillos/día. No alcohol.

Historia de la enfermedad actual

Refiere endurecimientos abdominales dolorosos cada 5-7 minutos desde hace 4 horas, con dolor lumbar y sensación de presión en pelvis. Nota aumento de flujo vaginal claro, sin sangrado franco. Refiere escozor al orinar desde hace días. Movimientos fetales presentes. Niega pérdida abundante de líquido (no está segura). No fiebre alta.

Exploración física

TA 118/70 mmHg, FC 92 lpm, Tª 37,6 °C. Abdomen: dinámica uterina palpable, 2-3 contracciones en 10 minutos, útero que se relaja entre contracciones. Especuloscopia: cérvix con cambios, escaso flujo, no se observa salida franca de líquido amniótico; test de cristalización/AmniSure no concluyente inicialmente. Tacto vaginal: cérvix borrado 50%, dilatado 2 cm. FCF 150 lpm.

Pruebas complementarias disponibles

- RCTG: dinámica uterina regular (2-3 contracciones/10 min), FCF reactiva sin desaceleraciones.
- Ecografía transvaginal: longitud cervical 18 mm (acortada).
- Fibronectina fetal: positiva.
- Tira de orina: leucocitos y nitritos positivos. Urocultivo pendiente.

- Hemograma: leucocitosis leve. PCR levemente elevada.
- Frotis vagino-rectal para SGB (estreptococo grupo B): pendiente.

Guion de comportamiento de la paciente virtual

Eres Sara, 29 años, embarazada de 30 semanas. Estás nerviosa porque notas contracciones y te da miedo que el bebé nazca antes de tiempo. Hablas con normalidad. Cuentas que tienes escozor al orinar (si preguntan) y que llevas días así. No estás segura de si has "roto aguas"; dices que notas más flujo pero no un chorro claro. Reconoces que fumas algo si te preguntan. Preguntas si tu bebé va a estar bien.

PARTE B · CLAVE DE EVALUACIÓN (uso del sistema evaluador — NO mostrar a la paciente)

Diagnóstico principal

Amenaza de parto pretérmino (APP) a las 30 semanas (dinámica regular + cérvix acortado <25 mm + fibronectina positiva), con infección urinaria como posible factor desencadenante.

Diagnóstico diferencial

- Contracciones de Braxton-Hicks
- Rotura prematura de membranas pretérmino
- Desprendimiento de placenta
- Infección urinaria/pielonefritis
- Corioamnionitis

Datos clave de anamnesis que debe obtener el alumno

- Características de la dinámica (frecuencia, dolor, duración).
- Descartar rotura de membranas (pérdida de líquido) y sangrado.
- Síntomas urinarios (factor desencadenante frecuente).
- Factores de riesgo: tabaco, aborto previo, infección.

Pruebas que debería solicitar

- RCTG para objetivar dinámica y bienestar fetal.
- Ecografía transvaginal: longitud cervical.
- Fibronectina fetal (valor predictivo negativo alto).
- Tira/sedimento y urocultivo; descartar infección.
- Frotis para SGB; valorar amniorrexia (test específico).

Manejo / tratamiento correcto

Ingreso. Tocólisis (atosibán o nifedipino) para ganar tiempo. Corticoides para maduración pulmonar fetal (betametasona, 2 dosis). Sulfato de magnesio para neuroprotección fetal (<32 semanas). Tratar la infección urinaria con antibiótico. Profilaxis de SGB intraparto si procede. Considerar traslado a centro con UCI neonatal. Valorar bienestar fetal de forma continuada.

Rúbrica de evaluación

Criterio evaluado	Puntos
Caracteriza la dinámica y descarta rotura de membranas y sangrado	15
Detecta y trata la infección urinaria como desencadenante	15
Solicita longitud cervical ± fibronectina	15
Diagnostica amenaza de parto pretérmino	15
Indica corticoides para maduración pulmonar	20
Añade tocólisis y sulfato de magnesio (neuroprotección <32 sem)	20
TOTAL	100

Errores frecuentes / banderas rojas

- Dar el alta interpretando las contracciones como Braxton-Hicks.
- Olvidar los corticoides de maduración pulmonar.
- No descartar/tratar la infección urinaria.
- Usar tocólisis sin valorar contraindicaciones (corioamnionitis, sufrimiento fetal).